

Cáncer gástrico y colorrectal

1. Introducción y relevancia clínica

El **cáncer gástrico** y el **cáncer colorrectal (CCR)** representan las **neoplasias malignas digestivas más frecuentes en Chile** y una causa importante de **mortalidad oncológica**.

- **Cáncer gástrico:**
 - Chile tiene una de las tasas más altas de América Latina (10–15/100.000 hab.).
 - Alta mortalidad por diagnóstico tardío.
 - Relación directa con *Helicobacter pylori* y dieta rica en sal, ahumados y nitrosaminas.
- **Cáncer colorrectal:**
 - En aumento en las últimas décadas.
 - Segunda causa de muerte por cáncer en el país.
 - Asociado a dieta occidental, obesidad, sedentarismo y antecedentes familiares.

Ambos tumores son **GES**, lo que garantiza el **diagnóstico, tratamiento y seguimiento** dentro del sistema público y privado.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Cáncer gástrico

Etiología

- **Helicobacter pylori** (principal factor de riesgo).
- **Dieta:** alta en sal, nitritos, ahumados; baja en frutas y verduras.
- **Tabaquismo y alcohol.**

- **Factores genéticos:**
 - Cáncer gástrico hereditario difuso (mutación *CDH1*).
 - Historia familiar de primer grado.
- **Lesiones precursoras:** gastritis crónica atrófica, metaplasia intestinal, displasia.
- **Cirugía gástrica previa** (gastrectomía parcial) tras >15 años.

Patogenia

Secuencia clásica:

Infección por H. pylori → gastritis crónica → atrofia → metaplasia intestinal → displasia → carcinoma.

Tipos histológicos (Lauren)

Tipo	Características
Intestinal	Asociado a H. pylori, ambiente, metaplasia intestinal, mejor pronóstico
Difuso	Células en anillo de sello, infiltrante, afecta jóvenes, peor pronóstico

2.2 Cáncer colorrectal (CCR)

Etiología

- **Adenomas adenomatosos** (adenoma-carcinoma sequence).
- **Predisposición genética:**
 - Síndrome de Lynch (HNPCC): cáncer colorrectal + endometrial precoz.
 - Poliposis adenomatosa familiar (PAF): mutación *APC*.
- **Factores ambientales:**
 - Dieta rica en grasas y carnes rojas.

- Obesidad, sedentarismo, alcohol y tabaco.
- **Enfermedades inflamatorias intestinales:** colitis ulcerosa crónica (>10 años).

Secuencia adenoma-carcinoma

Mutaciones acumuladas (*APC* → *KRAS* → *p53*), con progresión de adenoma benigno a carcinoma invasor en 5–10 años.

Localización

- Colon izquierdo (descendente, sigmoides): 60%.
 - Colon derecho (ciego, ascendente): 30%.
 - Resto: recto.
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Cáncer gástrico

Síntomas iniciales (inespecíficos)

- Dispepsia persistente.
- Dolor epigástrico.
- Saciedad precoz.
- Náuseas, pérdida de apetito.
- Pérdida de peso y anemia ferropénica.

Síntomas tardíos

- Vómitos (por obstrucción).
- Hematemesis o melena.
- Masa palpable epigástrica.
- Adenopatía supraclavicular izquierda (nódulo de Virchow).

- Metástasis ováricas (tumor de Krukenberg).

Todo paciente >40 años con dispepsia persistente o anemia ferropénica debe estudiarse con endoscopia.

3.2 Cáncer colorrectal

Síntomas según localización

Localización	Síntomas predominantes
Colon derecho	Anemia ferropénica, astenia, pérdida de peso, masa palpable, sangrado oculto
Colon izquierdo	Cambios en el ritmo intestinal (constipación alternada con diarrea), hematoquezia, obstrucción parcial
Recto-sigmoides	Rectorragia, tenesmo, pujo, dolor rectal

Síntomas generales

- Pérdida de peso, anorexia, anemia.
 - En fases avanzadas: obstrucción intestinal o perforación.
-

3.3 Diagnóstico diferencial

Cáncer gástrico	Cáncer colorrectal
Úlcera péptica, linfoma gástrico, gastritis erosiva	Hemorroides, colitis, diverticulosis, síndrome de intestino irritable

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Cáncer gástrico

- **Endoscopía digestiva alta con biopsia múltiple:**
 - *Gold standard* diagnóstico.
 - Permite definir tipo histológico y grado de invasión.
 - **TAC de tórax, abdomen y pelvis:**
 - Estadificación local y a distancia (metástasis hepática, pulmonar, peritoneal).
 - **Ecoendoscopía:**
 - Evalúa profundidad (T) y ganglios regionales (N).
 - **CA 19-9 y CEA:** marcadores pronósticos, no diagnósticos.
-

4.2 Cáncer colorrectal

- **Colonoscopia total con biopsia:** *Gold standard*.
 - Permite detección y resección de pólipos.
 - **TAC abdominopélvico:** extensión local y metástasis.
 - **RM de pelvis:** esencial en cáncer de recto (para T y N).
 - **CEA sérico:** marcador pronóstico y seguimiento postoperatorio.
 - **Colon por enema o TAC-colonografía:** alternativa si colonoscopia incompleta.
-

4.3 Estadificación TNM (simplificada)

Estadio	Cáncer gástrico / colorrectal	Tratamiento
---------	----------------------------------	-------------

I-II	Localizado, sin metástasis	Cirugía curativa
III	Ganglios positivos	Cirugía + quimioterapia adyuvante
IV	Metástasis a distancia	Quimioterapia paliativa ± cirugía

5. Tratamiento (según guías MINSAL / NCCN / ESMO)

5.1 Cáncer gástrico

Tratamiento quirúrgico (base del manejo curativo)

- **Gastrectomía subtotal (antrectomía):** para tumores del antro o distal.
- **Gastrectomía total:** para tumores del cuerpo o cardias.
- **Linfadenectomía D2 (estándar):** resección de ganglios perigastricos y perigástricos.
- Reconstrucción tipo Roux-en-Y.

Tratamiento complementario

- **Quimioterapia adyuvante:** esquema FOLFOX o CAPOX.
- **Neoadyuvancia (preoperatoria):** útil en tumores localmente avanzados.
- **Radioterapia:** menos utilizada, solo en casos seleccionados.

Tratamiento paliativo

- En metástasis:
 - Quimioterapia paliativa (FOLFOX, FOLFIRI).
 - Gastroenteroanastomosis o prótesis endoscópica si obstrucción.
-

5.2 Cáncer colorrectal

Tratamiento quirúrgico

- **Colectomía segmentaria** con márgenes oncológicos y linfadenectomía ≥ 12 ganglios.
- **Resección anterior baja o amputación abdominoperineal** para cáncer de recto.
- **Cirugía laparoscópica**: igual eficacia oncológica.

Tratamiento complementario

- **Quimioterapia adyuvante (estadios III y II de alto riesgo):**
 - Esquemas FOLFOX (5-FU + oxaliplatino).
- **Radioterapia preoperatoria (neoadyuvante):**
 - En cáncer de recto localmente avanzado (T3–T4 o N+).

Tratamiento paliativo

- Resección o derivación del tumor obstructivo.
- Colostomía o prótesis endoluminal.
- Quimioterapia paliativa (FOLFIRI, FOLFOX).

5.3 Seguimiento y vigilancia (GES Chile)

Cáncer gástrico

- Control cada 3–6 meses (clínica + CEA).
- TAC anual.
- Endoscopia de control si cirugía subtotal.

Cáncer colorrectal

- **Colonoscopia de vigilancia:**

- A 1 año de la cirugía, luego cada 3–5 años.
- CEA cada 3–6 meses.
- TAC anual durante 5 años.

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Cáncer gástrico	Cáncer colorrectal
Recurrencia local o metástasis hepática	Alta, incluso tras cirugía	Común en hígado y pulmón
Fístula anastomótica	Postoperatoria	Riesgo alto en resección baja
Obstrucción intestinal o perforación	Por tumor avanzado	En localización distal
Síndrome de dumping	Tras gastrectomía	No aplicable

Pronóstico global:

- **Cáncer gástrico:** sobrevida 5 años ≈ 30%.
- **Cáncer colorrectal:** sobrevida 5 años ≈ 60–70% (si diagnóstico precoz).

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. Cáncer gástrico:

- Todo paciente >40 años con dispepsia o anemia ferropénica → **endoscopia**.
- Tipo intestinal se asocia a *H. pylori* y mejor pronóstico.
- El tratamiento curativo es **gastrectomía + linfadenectomía D2**.

2. Cáncer colorrectal:

- Toda **anemia ferropénica en hombre o mujer postmenopáusica** es **CCR hasta demostrar lo contrario**.
- **Colonoscopia total** es el diagnóstico de elección.
- **CEA elevado** no es diagnóstico, solo útil para seguimiento.
- El tratamiento quirúrgico es el único curativo.

3. Tamizaje:

- **Test de sangre oculta en deposiciones (SOH) anual** desde los 50 años (MINSAL).
- Colonoscopia si test positivo o antecedentes familiares.



Errores comunes

- No indicar **endoscopia** en dispepsia persistente o anemia.
 - Confiar en **test de H. pylori** sin confirmar con biopsia.
 - No solicitar **colonoscopia completa** ante sangrado rectal.
 - Usar CEA como diagnóstico en lugar de seguimiento.
 - No considerar quimioterapia adyuvante en estadios III.
 - Desconocer cobertura **GES** y flujograma de derivación oncológica.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Cáncer gástrico y colorrectal** son los tumores digestivos más frecuentes y mortales en Chile.
2. **Cáncer gástrico:** asociado a *H. pylori*, dieta salada, tipo intestinal/difuso.
3. **Cáncer colorrectal:** se origina en adenomas; riesgo aumenta con dieta occidental y antecedentes familiares.
4. **Diagnóstico:** endoscopía (gástrico) y colonoscopia (colorrectal) con biopsia.
5. **Tratamiento quirúrgico + quimioterapia adyuvante** es la base del manejo curativo.
6. **Tamizaje:** test de sangre oculta anual desde los 50 años, colonoscopia cada 10 años.
7. Ambos cánceres están cubiertos por **GES**, con protocolos de diagnóstico y tratamiento garantizados.